



PERÚ

Ministerio
de Salud

SECRETARIA GENERAL

OFICINA GENERAL DE
ASESORIA JURIDICA



Firmado digitalmente por OCHOA
SOTOMAYOR Juan Francisco FAU
20131373237 hard
Cargo: Director General
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 02.07.2026 16:19:25 -05:00

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres
"Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia"

Jesus Maria, 02 de Julio del 2026

INFORME N° D000703-2026-OGAJ-MINSA

A : **JULIO CESAR NIÑO BAZALAR**
SECRETARIO GENERAL
SECRETARIA GENERAL

De : **JUAN FRANCISCO OCHOA SOTOMAYOR**
DIRECTOR GENERAL
OFICINA GENERAL DE ASESORIA JURIDICA

Asunto : Opinión respecto al Proyecto de Ley N° 14720/2025-CR, Ley que declara el 29 de octubre de cada año como el "Día Nacional de Concientización sobre el Síndrome de RETT".

Referencia : a) Oficio N° 2715-2025-2026-CSP/CR
b) Memorándum N° D003336-2026-DGIESP-MINSA
(Expediente N° 2026-0175451)

Fecha : Jesús María, 02 de julio de 2026

Mediante el presente se informa sobre el Proyecto de Ley N° 14720/2025-CR, Ley que declara el 29 de octubre de cada año como el "Día Nacional de Concientización sobre el Síndrome de RETT", en adelante, el Proyecto de Ley.

I. ANTECEDENTES:

- 1.1 A través del documento de la referencia a), la Comisión de Salud y Población solicita la opinión sectorial del Proyecto de Ley.
- 1.2 Con el documento de la referencia b), la Dirección General de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública, a través de la Dirección de Prevención y Control de Enfermedades No Transmisibles, Raras y Huérfanas, ha remitido un informe técnico sobre el Proyecto de Ley.

II. BASE LEGAL:

- 2.1 Constitución Política del Perú.
- 2.2 Ley N° 26842, Ley General de Salud, y modificatorias.
- 2.3 Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo.
- 2.4 Ley N° 26889, Ley Marco para la Producción y Sistematización Legislativa.
- 2.5 Decreto Legislativo N° 1161, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Salud, y modificatorias.
- 2.6 Decreto Supremo N° 008-2017-SA, Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Salud.



Firmado digitalmente por FUENTES
CASTRO GOTELLI Jorge Augusto
FAU 20131373237 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 02.07.2026 10:17:55 -05:00



Firmado digitalmente por RECOBA
VEGA Stephany Paola FAU
20131373237 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 02.07.2026 10:15:59 -05:00

III. ANÁLISIS

A) Contenido del Proyecto de Ley

- 3.1 El Proyecto de Ley cuenta con un artículo único que propone declarar el 29 de octubre de cada año como el "Día Nacional de Concienciación sobre el Síndrome de Rett" en todo el territorio nacional.

B) Sobre las competencias del Ministerio de Salud

- 3.2 Los numerales I y II del Título Preliminar de la Ley N° 26842, Ley General de Salud, disponen que la salud es condición indispensable del desarrollo humano y medio fundamental para alcanzar el bienestar individual y colectivo, y que es responsabilidad del Estado regularla, vigilarla y promoverla. El artículo 123 establece que la Autoridad de Salud de nivel nacional es el órgano especializado del Poder Ejecutivo que tiene a su cargo la dirección y gestión de la política nacional de salud y actúa como la máxima autoridad normativa en materia de salud.
- 3.3 En ese sentido, la Primera Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo N° 1161, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Salud, señala que el Ministerio de Salud es la Autoridad de Salud a nivel nacional, según lo establece la Ley 26842, Ley General de Salud, tiene a su cargo la función rectora a nivel nacional, la formulación, dirección y gestión de la política nacional de salud y es la máxima autoridad rectora en el sector. Su finalidad es la promoción de la salud, la prevención de enfermedades, la recuperación de la salud y la rehabilitación de la salud de la población.
- 3.4 De conformidad con lo dispuesto en los artículos I y VI del Título Preliminar de la Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, las entidades que conforman el Poder Ejecutivo se rigen, entre otros, por el principio de legalidad, según el cual, las autoridades, funcionarios y servidores del Poder Ejecutivo están sometidos a la Constitución Política del Perú, a las leyes y a las demás normas del ordenamiento jurídico, desarrollando sus funciones dentro de las facultades que les estén conferidas, y por el principio de competencia, por el que dicho Poder del estado ejerce sus atribuciones sin asumir funciones o atribuciones que son cumplidas por los otros niveles de gobierno o sectores.

Asimismo, según el artículo 22 de la citada Ley, los Ministerios son organismos del Poder Ejecutivo que comprenden uno o varios sectores. Su ámbito de competencia se establece en su Ley de Organización y Funciones.

- 3.5 Conforme lo dispone el artículo 2 del Decreto Legislativo N° 1161, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Salud, éste es un organismo del Poder Ejecutivo y órgano rector en materia de salud a nivel nacional. El artículo 3 de la misma norma prescribe que el Ministerio de Salud es competente en: 1) Salud de las personas; 2) Aseguramiento en salud; 3) Epidemias y emergencias sanitarias; 4) Salud ambiental e inocuidad alimentaria; 5) Inteligencia sanitaria; 6) Productos farmacéuticos y sanitarios, dispositivos médicos y establecimientos farmacéuticos; 7) Recursos humanos en salud; 8) Infraestructura y equipamiento en salud; y, 9) Investigación y tecnologías en salud.

- 3.6 El Ministerio de Salud cumple sus funciones a través de sus órganos de línea y desconcentrados y organismos adscritos, conforme al Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Salud, aprobado por Decreto Supremo 008-2017-SA, en cuyo marco se emite la opinión respectiva.

C) Opinión técnica

- 3.7 La **Dirección General de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública (DGIESP)**, mediante Informe N° D000047-2026-DGIESP-DENOT-LGO-MINSA de la Dirección de Prevención y Control de Enfermedades No Transmisibles, Raras y Huérfanas, remite opinión señalando lo siguiente:

3.7.1 Criterio Clínico y Epidemiológico-Síndrome de Rett (F84.2)

- Clasificación en Orphanet: De acuerdo con la base de datos europea de referencia sobre enfermedades raras y medicamentos huérfanos (Orphanet), el Síndrome de Rett está registrado bajo el código ORPHA:778. Es definido como un trastorno del neurodesarrollo severo de origen genético (ligado principalmente a mutaciones en el gen MECP2), que afecta casi exclusivamente a mujeres y se caracteriza por una regresión psicomotora, pérdida del uso propositivo de las manos, estereotipias manuales y microcefalia postnatal.
- Inclusión en Grupos Nosológicos de Baja Prevalencia: Orphanet y la Organización Mundial de la Salud (OMS) catalogan al Síndrome de Rett dentro de grupos macro, específicamente bajo el espectro de "Trastornos raros del desarrollo neurológico". Desde el punto de vista de la gestión en salud, la base científica internacional no justifica aislar el ORPHA:778 de su grupo matriz para otorgarle una efeméride propia. Las necesidades clínicas, de investigación y de soporte tecnológico de este síndrome son compartidas por cientos de otras encefalopatías del neurodesarrollo de baja prevalencia, por lo que individualizarlo normativamente resulta innecesario y discriminatorio para pacientes con patologías de similar gravedad clínica.

3.7.2 Contradicción con el Enfoque Global de Integración y Equidad

- Riesgo de fragmentación: Según la exposición de motivos del Reglamento de la Ley 29698, "Las enfermedades raras, aunque por su misma definición tengan una baja prevalencia de manera individual, colectivamente afectan a una proporción significativa de la población general", además el número exacto de enfermedades raras también carece de una estandarización consensuada, y las cifras citadas con frecuencia varían entre 5,000 y 8,000 enfermedades raras¹; según la data de Orphanet y, en la Resolución Ministerial N° 230-2020-MINSA se aprueba el documento técnico: Listado de Enfermedades Raras o Huérfanas, que incluye 546 diagnósticos con sus respectivos códigos CIE10. Entonces, promover declaratorias exclusivas para afecciones individuales generaría una saturación del calendario conmemorativo y atomizaría los esfuerzos de sensibilización. Actualmente ya existen marcos normativos generales (como el Día Nacional de las

¹ The Lancet Neurology. (2011). Rare neurological diseases: A united approach is needed. The Lancet Neurology, 10(2), 109

Enfermedades Raras o Huérfanas) que agrupan y visibilizan patologías de baja prevalencia, incluido el Síndrome de Rett. La sobrepoblación de días conmemorativos específicos resta impacto a las campañas globales de salud.

- Lineamientos de la OMS: De acuerdo con la resolución WHA78.11 de la 78.^a Asamblea Mundial de la Salud (mayo 2025), se urge a los Estados miembros a adoptar políticas holísticas y centradas en la persona, integrando las enfermedades raras dentro de los planes nacionales generales para consolidar la Cobertura Sanitaria Universal, en lugar de atomizar las respuestas institucionales.

3.7.3 Duplicidad con el Marco Normativo Nacional de Enfermedades Raras (ERH)

- Marco protector integral preexistente: El Estado peruano cuenta con la Ley 29698 y su reglamento que fue aprobado mediante Decreto Supremo N° 002-2025-SA, la cual declara de interés nacional y preferente atención el tratamiento de las personas que padecen de ERH de manera colectiva y equitativa. La legislación vigente ya faculta al Ministerio de Salud (MINSA) a realizar campañas de prevención, diagnóstico e inclusión para este tipo de condiciones sin necesidad de promulgar una ley declarativa adicional.

3.7.4 Eficiencia en la Asignación Presupuestaria y Sostenibilidad

- Estructura presupuestal unificada: El financiamiento público para estas patologías en el Perú no se gestiona de manera aislada por enfermedad, sino que se encuentra centralizado en la categoría presupuestal APNOP (Actividad 5001566 "Otras Actividades de Salud Especializadas"), Asimismo, para el año 2026 en el presupuesto de salud pública se han programado S/ 166.9 millones bajo la actividad Presupuestal 5006441(tratamiento de enfermedades raras y huérfanas) gestionado este último a través del Seguro Integral de Salud (SIS), el FISSAL. Priorizar simbólica o políticamente una sola patología debilita los criterios éticos de equidad distributiva que rigen la inversión en salud pública.

D) Opinión de la Oficina General de Asesoría Jurídica

- 3.8 De la revisión de la normativa vigente, se constata que, ya existe un marco protector integral establecido en la Ley N° 29698 y su reglamento, aprobado mediante el Decreto Supremo N° 002-2025-SA. Esta normativa ya declara de interés nacional y preferente atención el tratamiento de las personas con Enfermedades Raras o Huérfanas (ERH) de manera equitativa y colectiva.

En consecuencia, la legislación actual ya faculta al Ministerio de Salud para realizar campañas de prevención, diagnóstico e inclusión, por lo que resultaría redundante promulgar una ley declarativa adicional.

- 3.9 En concordancia con lo señalado por la DGIESP, desde una perspectiva técnico-jurídica, la individualización normativa del Síndrome de Rett mediante una declaratoria exclusiva resulta innecesaria y advierte un trato discriminatorio



PERÚ

Ministerio
de Salud

SECRETARIA GENERAL

OFICINA GENERAL DE
ASESORIA JURIDICA

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia"

frente a los pacientes que padecen otras encefalopatías del neurodesarrollo de baja prevalencia y de similar gravedad clínica. La aprobación de la iniciativa genera un riesgo de fragmentación normativa y saturación del calendario conmemorativo, lo cual contraviene el principio de equidad y resta impacto a las políticas integrales de salud, máxime cuando el ordenamiento actual ya contempla el Día Nacional de las Enfermedades Raras o Huérfanas, fecha que visibiliza y tutela de manera conjunta a todas estas patologías.

IV. CONCLUSIÓN:

Por lo anteriormente expuesto, en el marco de las competencias del Ministerio de Salud, en relación al Proyecto de Ley N° 14720/2025-CR, Ley que declara el 29 de octubre de cada año como el "Día Nacional de Concientización sobre el Síndrome de RETT", se sugiere que este sea reevaluado a fin de determinar su necesidad, considerando para ello las observaciones y comentarios señalados en el presente Informe.

Se adjunta el proyecto de Oficio para el Congreso de la República.

Lo que informo a Usted para su conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente,

Documento firmado digitalmente

JUAN FRANCISCO OCHOA SOTOMAYOR
DIRECTOR GENERAL
OFICINA GENERAL DE ASESORIA JURIDICA

(JOS/jfcg/srv)

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia"

Jesus Maria, 06 de Julio del 2026

OFICIO N° D002014-2026-DM-MINSA

Señora Congressista
MAGALY ROSMERY RUÍZ RODRÍGUEZ
Presidenta
Comisión de Salud y Población
Congreso de la República del Perú
Presente.-

Asunto : Opinión sobre el Proyecto de Ley N° 14720/2025-CR

Referencia : Oficio N° 2715-2025-2026-CSP/CR
Expediente N° 2026-0175451

De mi consideración:

Es grato dirigirme a usted para saludarla cordialmente y, con relación al documento de la referencia, mediante el cual solicita opinión respecto al Proyecto de Ley N° 14720/2025-CR, que declara el 29 de octubre de cada año como el "Día Nacional de Concientización sobre el Síndrome de RETT".

Al respecto, se remite copia del Informe N° D000703-2026-OGAJ-MINSA, elaborado por la Oficina General de Asesoría Jurídica del Ministerio de Salud, para conocimiento y fines pertinentes.

Hago propicia la oportunidad para expresarle los sentimientos de mi especial consideración.

Atentamente,

Documento firmado digitalmente

JUAN CARLOS VELASCO GUERRERO
MINISTRO DE SALUD

JCVG/sg



Firmado digitalmente por NIÑO BAZALAR Julio Cesar FAU 20131373237 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 06.07.2026 16:37:23 -05:00



Firmado digitalmente por REBAZA IPARRAGUIRRE Henry Alfonso FAU 20131373237 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 06.07.2026 16:37:23 -05:00

At: 06072026 16:38:00, Jesús María
Central Telefónica: (01) 315 6600
<https://www.gob.pe/minsa>

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado en el Ministerio de Salud, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web:
<https://sgd.minsa.gob.pe/validadorDocumental/inicio/detalle.jsf> e ingresando el siguiente Código de Verificación: **MY5QWBW**

